

ДІАГНОСТИЧНА ПЛЕВРАЛЬНА ПУНКЦІЯ

Ви черговий хірург лікарні. Бригадою швидкої медичної допомоги до приймального відділення доставлений пацієнт 40 років з діагнозом: “Закрита травма грудної клітини”.

Скарги: на інтенсивну біль у лівих відділах грудної клітини, неможливість зробити глибокий вдих, задиху, загальну слабкість.

Анамнез захворювання: Травма у побуті: годину назад через необережність впав з висоти власного зросту та вдарився лівою половиною грудної клітини о стілець. Після чого відчув сильний біль у місці травми, що стало причиною виклику БШМД.

Анамнез життя: Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає.

Спадковість: необтяжена.

Об’єктивно: стан середньої тяжкості, у свідомості, положення вимушене - ортопное.

Шкіра блідо-рожева, суха. Ріст 180 см, вага 83 кг. Периферичний набряків немає. В акті дихання відстає ліва половина грудної клітини, в 5-7 міжребер’ях за середньою пахвовою лінією підшкірна гематома 5*7 см та садна. При пальпації різка болючість у 5-7 міжребер’ях за середньою пахвовою лінією та крепітація ребер. Підшкірної емфіземи немає. При порівняльній перкусії: справа - ясний легеневиий звук; зліва від 5 ребра за середньою пахвовою лінією притуплення перкуторного звуку. При аускультатії легень справа - жорстке дихання; зліва дихання послаблене нижче 5 ребра не вислуховується. ЧДР 26 за хв. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця ясні ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=Пс=102 за хв., АТ ліва рука 110/70 мм рт.ст., АТ права рука 110/ 70 мм рт.ст. Живіт невдутий, приймає участь у акті дихання. При пальпації м’який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Щьоткіна-Блюмберга негативний. **Аускультативно** - перистальника є. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються.

Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Додатково:

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення	Референтні значення
Гемоглобін г/л	88	130-160г/л – для чоловіків 120-140г/л - для жінок
Еритроцити 10 ¹² /л	2,9	4,0-5,0×10 ¹² /л – для чоловіків 3,9-4,7×10 ¹² /л –для жінок

Кольоровий показник	0,75	0,85-1,15
Тромбоцити 10 ⁹ /л	170	180-320×10 ⁹ /л
Лейкоцити 10 ⁹ /л	12,0	4,0-9,0×10 ⁹ /л
- лімфоцити%	14	19-37%
- еозінофіли %	-	0,5-5,0%

- палочкоядерні нейтрофіли %	6	0-5,0%
- сегментоядерні нейтрофіли %	75	47,0-72,0%
- моноцити %	5	3,0 – 11,0 %
ШОЕ	12	1 – 10 мм/ч – для чоловіків 2 – 15 мм/ч – для жінок

Біохімічний аналіз крові

Показник	Значення	Референтні значення
Загальний білок	58,0	60-80 г/л
Глюкоза	5,5	3,3-5,5 ммоль/л
АлАТ	0,45	0,1-0,68 мкмоль/л
АсАТ	0,45	0,1-0,45 мкмоль/л
Холестирин	5,2	3,9-5,2 ммоль/л
Білірубін загальний	18,6	8,5-20,5 мкмоль/л
Білірубін прямий	4,9	1,05-5,4 мкмоль/л
Білірубін непрямий	13,7	6,5-15,4 мкмоль/л
Креатинин крові	95	44-97 мкмоль/л
Сечовина крові	6,0	2,5-6,4 ммоль/л

Оглядова рентгенографія органів грудної клітини



12. Інструкція для стандартизованого пацієнта (за необхідності, якщо це передбачено умовами роботи на станції).

№п/п	Дії	Текст
1. Комунікативні навички		
1.1	Привітатися.	Доброго дня.
1.2	Ви даєте свою згоду на проведення клінічного обстеження?	Так
Збір скарг та анамнезу		
2.1	Які у Вас скарги?	на інтенсивну біль у лівих відділах грудної клітини, неможливість зробити глибокий вдих, задуху, загальну слабкість.
2.2	Коли з'явилися скарги, що з	Травма у побуті: годину назад через
	Вами трапилось?	необережність впав з висоти власного зросту та вдарився лівою половиною грудної клітини о стілець. Після чого відчув сильний біль у місці травми, що стало причиною виклику БШМД.
2.3	Якими захворюваннями перехворіли? Чи є алергія? Чи були операції?	Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.

3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.	Під час огляду пацієнта виявлено асиметрію грудної клітки за рахунок відставання у диханні лівої половини. Спостерігається підшкірна гематома 5×7 см та садна в ділянці 5–7 міжребер'їв по середній пахвовій лінії. Дихання поверхневе, частота – 26/хв. Шкіра блідо-рожева, без ознак ціанозу. Ознак гіпоксії не виявлено.
3.2	Пальпація з верифікацією виявлених патологічних змін	При пальпації грудної клітки зліва виявлена різка болючість у 5–7 міжребер'ях по середній пахвовій лінії. Визначається крепітація ребер у цій ділянці, що свідчить про можливий перелом. Підшкірної емфіземи не виявлено
3.3	Перкусія з верифікацією виявлених патологічних змін	При порівняльній перкусії зліва від 5-го ребра виявлено притуплення перкуторного звуку, що свідчить про наявність рідини в плевральній порожнині. Праворуч – ясний легеневиий звук.
3.4	Аускультация з верифікацією виявлених патологічних змін	При аускультції легень – справа дихання жорстке, зліва нижче 5-го ребра дихання ослаблене та не вислуховується, що підтверджує підозру на гемоторакс.
4.Діагностика		
4.1	Проаналізувати клінічний аналіз крові	Визначено анемію (гемоглобін 88 г/л, еритроцити – $2,9 \times 10^{12}/л$, кольоровий показник – 0,75). Лейкоцитоз ($12,0 \times 10^9/л$), нейтрофіліоз (сегментоядерні – 75%), що свідчить про запальний процес, ймовірно посттравматичного генезу.
4.2	Проаналізувати оглядову рентгенографію органів грудної клітини	На рентгенограмі візуалізується затемнення нижньої частини лівої легені з рівнем рідини, що підтверджує діагноз гемотораксу. Можливі переломи ребер.
4.3	Встановити попередній клінічний діагноз	Закрита травма грудної клітки. Гемоторакс зліва. Перелом 5–7 ребер
5. Визначення тактики ведення та лікування		

5.1	Медикаментозна терапія, фізіотерапія, особливості харчування	Госпіталізація до відділення торакальної хірургії. Проведення плевральної пункції або дренажування. Катетерізація периферичної вени, інфузія 0,9% NaCl, 5% глюкоза. Призначення знеболювальних (НПЗП анальгін 50% 2мл, морфін 1мл за потребою), антибіотик (в/в аугментін 1200 мг 3 р на добу). Контроль гемодинаміки, динамічний моніторинг показників крові. Легке дієтичне харчування, збагачене білками та залізом. Гемтостатика – діцинон в/в 250 мг – 2 мл.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	Рекомендовано уникати побутових травм, дотримуватися техніки безпеки вдома. Після стабілізації – дихальна гімнастика, ЛФК. Профілактика ускладнень – рання активізація, контроль інфекцій, вакцинація (грип, пневмокок).
7.Інше		
7.1	Інформування пацієнта про можливі ризики хвороби	Пацієнт проінформований про наявність внутрішнього крововиливу в плевральну порожнину, можливість дихальної недостатності, інфекційних ускладнень. Надані роз'яснення щодо плану обстеження і лікування.

Чек-лист до практичної навички «Діагностична плевральна пункція»

№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення	Сказати



	контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль, визначити особливості анамнезу (алергічні реакції на ліки))	
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки хірургічним способом (лікар в рукавичках), надіти стерильний одяг, окуляри	Виконати
4	Коректний вибір місця пункції (6-7 міжребер'я по середній пахвовій лінії)	Сказати, Показати
5	Коректно обробити місце пункції розчином антисептику (широко марлевою серветкою у пінцеті, другою марлевою серветкою у пінцеті)	Виконати
6	Провести анестезію передбачуваного місця пункції	Сказати
7	Коректно виконати пункцію: - приєднати пункційну голку з до шприцу - ввести голку у місце пункції вільною рукою - перпендикулярно поверхні шкіри, по верхньому краю ребра, натягуючи шкіру - повільно просунути голку вглиб по верхньому краю ребра, безперервно потягуючи поршень на себе - при появі рідини в шприці припинити просування голки	Виконати
8	Евакуювати (за наявності) весь об'єм рідини з плевральної порожнини	Виконати
9	Накласти асептичну пов'язку на місце пункції. Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

